

Conjuntivitis

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
Infectología Pediátrica de Paganini
AEP
Normas H. Gutierrez

Conjuntivitis Neonatal

Es aquella que se presenta dentro del primer mes de vida.

Incidencia entre 1,6 y 12%.

La infección por *Chlamydia* es la causa más frecuente de conjuntivitis en el recién nacido.

En ausencia de infecciones transmitidas sexualmente, la conjuntivitis neonatal es producida fundamentalmente por *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus* spp, y *Streptococcus viridans*. En este periodo de la vida los virus no juegan un rol preponderante con excepción del *Herpes simplex*.

El sistema inmune del neonato es inmaduro, existe una secreción escasa de lágrimas, así como de lisozima y ausencia de inmunoglobulina A, lo cual favorece las infecciones oculares.

Epidemiología

Chlamydia

Es la causa más frecuente. Los recién nacidos de madres infectadas y no tratadas tienen un riesgo de adquirir la infección de 60 a 70%. De ellos, entre el 20 y el 50% desarrollarán conjuntivitis y entre el 10 y el 20% neumonía. La *Neisseria gonorrhoeae*: fue la causa más severa e importante de oftalmía neonatal y representó el 26% de los casos de ceguera en niños en edad escolar entre los años 1906 y 1911. Con el advenimiento de la profilaxis rutinaria de la oftalmía neonatal la misma disminuyó drásticamente.

Es indispensable realizar un examen microbiología en busca del gonococo de modo rutinario en toda mujer embarazada en su primer control prenatal y en caso de tratarse de poblaciones con alto riesgo de adquisición de infección gonocócica debe repetirse en el segundo trimestre del embarazo. Herpes simples: puede comprometer y ocasionar daño grave y severo en el ojo.

Conjuntivitis por *C. trachomatis*

Se presenta habitualmente entre los 5 y 14 días de vida. En los casos de ruptura prematura de membranas puede aparecer precozmente (3' días). Menos frecuentemente se puede presentar de tardíamente (60 días).

Manifestaciones clínicas:

- Tumefacción ocular
- Eritema y descarga ocular uní o bilateral mucopurulenta, esta inicialmente puede tener características acuosas, en estos casos la córnea no suele estar afectada excepto en el caso de la formación de micropannus.
- Es excepcional la aparición de pseudomembrana.

La complicación más frecuente de la infección por *C. trachomatis* fuera del ojo es la neumonía. La incidencia de la misma varía entre el 11 y 20% en los pacientes infectados. Ocurre habitualmente dentro de los primeros tres meses de la vida y el niño se presenta sin fiebre, con congestión nasal, taquipnea y rales pulmonares diseminados. Los hallazgos radiológicos más frecuentes son: hiperinsuflación e infiltrado intersticial y alveolar.

Oftalmía neonatal por *N. Gonorrhoeae*

Aparece típicamente entre los 2 y 7 días de vida. Si bien pueden evidenciarse manifestaciones clínicas en la segunda semana de vida, eso es muy poco frecuente. El neonato presenta edema de párpados y una descarga ocular purulenta. Como regla, la respuesta inflamatoria ocular externa es de menor magnitud que en los niños más grandes o adultos. Una vez instaurado el tratamiento, la secreción conjuntival puede continuar entre 7 y 14 días, lo cual puede contribuir a la formación de cicatrices conjuntivales.

Como manifestaciones extraoculares de la infección gonocócica se ha descrito que a través de la colonización faríngea se puede producir bacteriemia y con ello diseminar la enfermedad a distancia comprometiendo particularmente las articulaciones.

Herpes Simplex

Aparece entre los 6 y 14 días de vida. En los recién nacidos que estuvieron expuestos a ruptura prolongada de membranas pueden tener manifestaciones clínicas en el nacimiento. La conjuntivitis puede ser uni o bilateral y se acompaña de edema de párpado ipsilateral y secreción ocular serosa. No se puede distinguir de las otras causas de conjuntivitis neonatal salvo por las lesiones herpéticas de la córnea o de las vesículas en la piel.

Tratamiento

Si el neonato presenta dentro de las primeras 48 horas de vida una conjuntivitis, ésta muy probablemente sea una química. En el caso de prolongarse más allá de ese periodo o bien aparecer luego de los dos días de vida, se debe examinar el exudado purulento detenidamente en la tinción. En el caso de no obtener resultados en el directo y con cultivos negativos puede tratarse de una conjuntivitis por *C. trachomatis*.

C. trachomatis

Antibióticos sistémicos para evitar la neumonitis: Eritromicina a 50 mg/kg/día dividido en 4 dosis durante 14 días o azitromicina a 20 mg/kg/día durante 3 días. Dado que se ha reportado la asociación entre la administración oral de eritromicina y la estenosis hipertrófica del píloro (EHP), se debe alertar a los padres sobre este posible riesgo.

El tratamiento tópico no es efectivo.

Los corticoides tópicos están contraindicados, ya que pueden prolongar la infección y dejar como secuelas cicatrices en la conjuntiva.

Oftalmía gonococcica

Ceftriaxona a 25-50 mg/kg/día, en dosis única en los casos de oftalmía neonatal no complicada (no exceder los 125 mg/día o cefotaxima a 50-100 mg/kg/día durante 7 días. El ojo debe ser irrigado con solución salina inicialmente en forma horaria, y luego cada 2 ó 3 horas hasta que desaparezca la secreción.

No es necesario el uso de antibióticos tópicos.

El neonato debe ser siempre hospitalizado y se sugiere descartar infección diseminada gonocócica.

En el caso de documentarse meningitis el tratamiento deberá continuarse por 10-14 días.

Virus herpes simplex

Aciclovir a 60 mg/kg/día intravenoso, por un mínimo de 14 días.

En caso de haber compromiso neurológico el mismo deberá extenderse por 21 días.

No deben utilizarse corticoides tópicos, dado que disminuyen las defensas y esto ocasiona mayor daño en la córnea.

Si existe queratoconjuntivitis se requiere de tratamiento tópico adicional. Se puede utilizar trifluridina 1% en gotas que se aplican cada 2 a 3 horas.

S. aureus

Aparece entre los cuatro y cinco días de vida. Generalmente, la enfermedad aparece como una conjuntivitis catarral leve, con hiperemia y secreción mucosa o mucopurulenta. No precisa tratamiento sistémico.

Puede ser tratada con eritromicina tópica o gotas con gentamicina

Conjuntivitis en niños

La infección ocurre través del contacto directo con dedos contaminados y en general es producida por patógenos de VAS. También el ojo puede ser inoculado a través de las secreciones respiratorias que se eliminan con la tos o el estornudo. Con menor frecuencia está involucrada la vía endógena de infección desde estructuras vecinas como el párpado, la cara o los senos para nasales.

División clínica

1. Agudas

Causas más frecuentes: infecciones, los alérgenos y las toxinas.

Del 65 al 80% son ocasionadas por bacterias y entre un 15 a 20% son debidas a virus.

Bacterianas

- *H. influenzae* no tipificable más frecuente, responsable del Síndrome otitis-conjuntivitis
- 2º en frecuencia: *S. pneumoniae*, *Streptococcus mitis* y *Moraxella catarrhalis*.
- *S. aureus* y *Staphylococcus epidermidis*: sí bien pueden colonizar el párpado sin ocasionar enfermedad, otras veces puede producir blefaroconjuntivitis e infección crónica de los párpados.
- Otras causas menos frecuentes:
 - *N. gonorrhoeae* que rara vez es causa de conjuntivitis a esta edad. Si no es diagnosticada oportunamente y tratada a tiempo son graves y pueden causar secuelas severas. Luego del primer año de vida la presencia de este microorganismo resulta de contagio sexual y se la puede aislar generalmente de la faringe, recto, mucosa genital y de la conjuntiva ocular.
 - *Neisseria meningitidis* si bien es un agente etiológico raro de conjuntivitis, puede complicarse con enfermedad sistémica (meningitis, meningococemia).

Conjuntivitis bacteriana

Signos y síntomas	{	Compromiso bilateral (generalmente)
		Secreción mucopurulenta
		Eritema palpebral
		Ojo rojo
		Sensación de cuerpo extraño.

Virales

- Adenovirus (serotipo 3 y 7): produce la llamada fiebre faringoconjuntival que afecta sobre todo a menores de 10 años y se *presente* con fiebre, faringitis y conjuntivitis. Se transmite sobre todo por medio de secreciones respiratorias.
Se ha relacionado su excreción prolongada en heces con las epidemias producidas en los natatorios.
Es la infección más común en niños mayores.
Los sorotipos 8, 9 y 37 producen la queratoconjuntivis epidémica (muy común)
- *Herpes simplex* produce una conjuntivitis folicular o bien una blefaroconjuntivitis.
- Enterovirus 70 y el coxsackievirus A24: producen conjuntivitis hemorragia aguda.



Conjuntivitis viral. Hipertrofia del tejido linfoide y formación de pseudomembranas
Conjuntivitis viral

- Sig. os y síntomas
- Edema palpebral
 - Linfadenopatía preauricular
 - Lagrimeo, ardor
 - Fotofobia, ojo rojo
 - Hemorragias subconjuntivales
 - Pseudomembranas y queratitis.

2. Crónicas

Son las de manejo más dificultoso ya que pueden llevar a la pérdida de la visión.

La causa más frecuente es la obstrucción del conducto lagrimal.

La blefaritis producida por *S. aureus* y *S. epidermis*, también son causa frecuente de infección crónica en los niños.

El tracoma producido por *C. trachomatis* es la causa más impórtame de ceguera, cicatrices e inflamación crónica.

Cuadro Clínico

Hiperemia de las conjuntivas: manifestación más frecuente. La dilatación y congestión de los vasos son mayores cerca de la periferia de la conjuntiva bulbar y se vuelven menos pronunciados en el margen corneano.

Secreción, la cual se debe a una exudación de células inflamatorias, fibrina y moco. La misma puede ser purulenta, mucopurulenta, fibrinosa o sanguinolenta, dependiendo del origen de la misma.

Todo esto puede estar acompañado por quemosis: pérdida de la transparencia normal de la conjuntiva que aparece engrosada por la infiltración tisular leucocitaria.

A veces pueden formarse papilas que generalmente aparecen en la conjuntiva tarsal, si éstas son numerosas pueden darle un aspecto aterciopelado a la conjuntiva, si bien no es específica, su presencia se relaciona sobre todo con infección bacteriana y alergia.

En las conjuntivitis virales, por *Chlamydia* spp. y en las tóxicas predomina la reacción conjuntival.

También se pueden formar membranas sobre todo en las conjuntivitis virales, pero también pueden observarse en las bacterianas. Al ser estas membranas removidas se puede observar una superficie sangrante.

En las conjuntivitis de causa viral, podremos ver compromiso corneano que se manifiesta como una sensación de cuerpo extraño, fotofobia, disminución de la visión o bien visión borrosa.

Diagnóstico diferencial

Clínica	Bacteriana	Viral
Inicio bilateral	30-75%	33%
Apariencia de la conjuntiva	Papilar o no específica	Folicular
Secreción	Mucopurulenta	Acuosa
Presencia de membrana conjuntival	Aparición tardía	Aparición temprana
Adenopatía periauricular	No	Si
Otitis concomitante	20-75%	10%

Tratamiento

La conjuntivitis aguda es generalmente autolimitada. Los antibióticos solo están indicados cuando sospechamos una conjuntivitis aguda bacteriana, para limitar la diseminación y acortar los síntomas. De los antibióticos tópicos más utilizados disponemos de la eritromicina, que en general es bien tolerada y es activa contra la mayoría de los patógenos. Hay que tener en cuenta que han ido apareciendo cepas de bacterias resistentes como *Haemophilus* spp., *Streptococcus* spp., *Moraxella* spp. entre otros.

La tobramicina: desventaja es activos contra los estreptococos, por lo cual se los debe reservar para el tratamiento de infecciones producidas por bacterias gram-negativas entéricas.

Otro grupo de antibióticos de utilidad son las fluorquinolonas tópicos (ciprofloxacina). Tienen amplio espectro, activas tanto frente a gram-positivos como gram-negativos. Pero dada la emergencia de resistencia a estos antibióticos, los mismos deben reservarse para casos de infecciones severas. Estos tratamientos tópicos en general son eficaces cuando se los administra cada 2 o 4 horas durante 7-10 días.

En el caso de una conjuntivitis por herpes simplex debe tratarse con trifluridina tópica al 1 ó 2% cada 2 horas durante 7 días. También puede utilizarse vidarabina al 3%. Este tipo de conjuntivitis tanto para su diagnóstico como para su manejo requiere de la consulta con el oftalmólogo. El uso de aciclovir oral puede ser conveniente en algunos casos severos.

CONJUNTIVITIS ALÉRGICA

Se consideran inflamaciones de causa inmune aquellas en las que el daño tisular está producido totalmente por una reacción de hipersensibilidad frente a un antígeno inocuo en ausencia de dicha reacción.

Tipo de conjuntivitis frecuente que aparece tanto en individuos con alergia conocida como en sujetos en los que la única manifestación de alergia es la presencia de una conjuntivitis.

1. Conjuntivitis alérgica estacional

Es el tipo más frecuente de conjuntivitis alérgica.

Se trata de una reacción de hipersensibilidad inmediata, tipo I, mediada por IgE a alérgenos específicos vehiculados por el aire, como polen (conjuntivitis tipo fiebre del heno), escamas de animales, plumas, esporas de hongos, polvo, ácaros, insectos y perfumes.

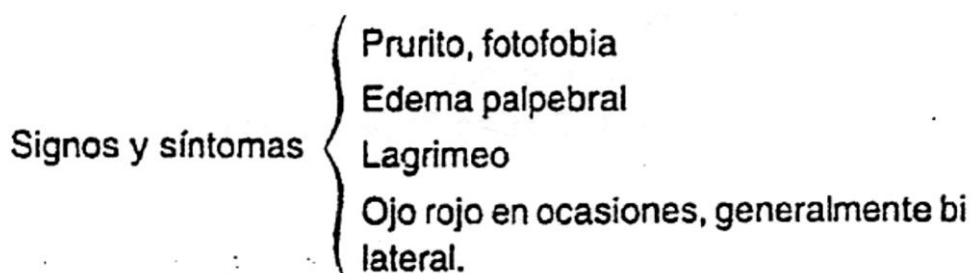
Suelen tener un carácter estacional o esporádico. Frecuentemente se asocian a rinitis concomitante y suele haber antecedentes personales y familiares de atopia. Las exacerbaciones se producen en primavera.

Síntomas y signos

El síntoma principal es el prurito e incluso se llega a dudar del diagnóstico si éste no se presenta. Se acompaña también de edema palpebral, hiperemia conjuntival y quemosis. Esta última, si es muy llamativa, puede ocultar la hiperemia. Se produce también secreción acuosa con lagrimeo, puede aparecer ptosis por el edema palpebral y es típica la ausencia de dolor.

La intensidad de los signos es variable y puede ser casi indistinguible de una conjuntiva normal. La rinitis y otros síntomas alérgicos asociados son frecuentes, por lo que su diagnóstico no suele resultar difícil.

Conjuntivitis alérgica



Tratamiento

El cuadro se resuelve espontáneamente y sin complicaciones en unos 3-4 días, aunque puede recurrir tras un nuevo contacto con el alérgeno.

Conviene tener en cuenta la frecuencia y la repercusión sistémica de los episodios.

Síntomas poco frecuentes: lavados oculares con agua fría y los colirios vasoconstrictores.

Con cierta frecuencia: estabilizadores de mastocitos: Ciclosporina tópica al 0.5% + antihistamínicos tópicos: Ketotifeno 2-4 veces al día y ocasionalmente sistémicos (difenhidramina). Estos últimos son útiles sobre todo si existe rinitis asociada.

Fases más severas de la enfermedad: corticoides tópicos, pueden controlar los síntomas de forma rápida y se deben aplicar por corto espacio de tiempo. Es de usos exclusivo por Oftalmología.

Queratoconjuntivitis Vernal

Es una inflamación bilateral, recurrente y, aunque suele presentar una exacerbación estacional, se trata de una enfermedad que permanece activa durante todo el año.

De amplia distribución en todo el mundo, aunque más frecuente en climas cálidos.

Empeora en los meses de primavera y verano, de ahí su nombre.

Habitualmente ocurre entre los 4 y los 20 años. En los niños es más frecuente en los varones, pero tras la pubertad la incidencia se iguala en ambos sexos.

Tiene una duración de entre 4 y 10 años.

Existe historia familiar de antecedentes de alergia en el 65%. El paciente con CV sufre en más de la mitad de los casos de otros tipos de enfermedades de naturaleza atópica, como fiebre del heno, asma, dermatitis atópica y alergia a alimentos, polvo y hongos.

Síntomas

El síntoma más prominente y característico es el prurito, que puede llegar a ser muy intenso. La fotofobia es otro síntoma importante en las crisis agudas y puede ser severa, lo cual es indicativo de afectación corneal.

Un lagrimeo abundante suele acompañar al picor y la fotofobia. Los pacientes también suelen quejarse de sensación de irritación ocular y enrojecimiento conjuntival.



Hipertrofia papilar en queratoconjuntivitis vernal

Tratamiento

Una parte importante del tratamiento es tranquilizar a los padres y a los pacientes (curso autolimitado), y prevenirles de las complicaciones propias de la enfermedad y de los tratamientos instaurados.

El traslado a un clima más frío y lluvioso es un remedio eficaz, pero habitualmente impracticable.

El uso de corticoides tópicos es muy efectivo, se debe recurrir a ellos sólo en momentos específicos, más agudos y recortados en el tiempo, dados sus potenciales efectos secundarios negativos y la prolongación en el tiempo de esta enfermedad.

Se han observado buenas respuestas con AINE tópicos, por lo que son una buena alternativa.

Otros: estabilizadores de mastocitos en forma tópica.